

APROBAT:

*Director interimar
al C.R.P.V.P.D. "Speranța",
Tatiana POPOVICI*

2025



**Codul de etică și conduit profesională
al angajatului
Centrului de Reabilitare a Persoanelor Vârstnice și
Persoanelor cu Dizabilități (adulte) "SPERANȚA"**

I. Dispoziții generale

1. Codul de conduita etică și profesională, în continuare Cod cadru, stipulează și încadrează valorile, principiile și normele de conduită obligatorii pentru personalul angajat în Centrului de reabilitare a persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) "SPERANTA".

2. Prevederile prezentului Cod nu contravin legislației Republicii Moldova, normelor și recomandărilor internaționale și nu exclud sau substituie prevederile actelor normative, regulamentelor și altor documente în vigoare care reglementează activitatea profesională medicală.

3. Cerințele Codului derivă din Jurămîntul lucrătorului medical și alte acte și norme ce reglementează relațiile de activitate a lucrătorului medical și stabilesc regulile morale pe care orice lucrător medical trebuie să le respecte.

4. Codul este menit să promoveze standardele și valorile morale supreme și să contribuie la conștientizarea unui comportament corespunzător de către toți membrii al Centrului „SPERANTA”.

5. Elaborarea Codului de conduită și etică profesională are la bază următoarele acte normative:

- Constituția
- Codul Muncii Republicii Moldova
- Codul cadru de etică (deontologic) al lucrătorului medical și farmacistului
- Codul de conduită, aprobat prin HG nr.664 din 30.08. 2013
- Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului din autoritățile și instituțiile publice.
- Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, nr.199 din 16.07.2010.
- Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158 din 04.07.2008
- Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public - Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.

II. Obiective

Obiectivele prezentului Cîd de conduita etica și profesională urmaresc sa asigure creșterea calității serviciului public, o bună administrare in realizarea interesului public, precum și eliminarea birocrăției și a faptelor de corupție, prin:

1. Reglementarea normelor de conduita profesionala necesare realizarii unor raporturi sociale si profesionale corespunzatoare creării si mențineril la nivel inalt a prestigiului institutiei publice și al personalului contractual;

2. Informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este indreptat să se aștepte din partea personalului contractual in exercitarea functiei;

III. Principii generale

Lucrătorul medical trebuie să fie model de comportament etico-profesional. În exercitarea profesiei, lucrătorul medical se ghidează de următoarele principii:

1) profesionalismul lucrătorul medical are obligația să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiință.

2) independență profesională - lucrătorul medical se bucură de independență profesională, libertatea prescripțiilor și actelor medicale pe care le consideră necesare, în limitele standardelor aprobate.

3) onestitate lucrătorul medical are obligația să exercite actele medicale conform competenței profesionale dobândite cu corectitudine. În exercitarea profesiei, lucrătorul medical trebuie să manifeste stimă față de alte persoane, acționând și discutând sincer și corect orice chestiune.

4) integritate - lucrătorul medical are obligația de a susține sănătatea fizică și mintală a omului, de a promova un mod sănătos de viață, de a preveni îmbolnăvirile și de a ușura suferințele, respectând dreptul la viață și demnitate al ființei umane, fără discriminări de vârstă, sex, rasă, etnie, religie, naționalitate, condiție socială, ideologie, politică sau din orice alt motiv.

5) respect și acceptare în exercitarea profesiei, lucrătorul medical trebuie să fie tolerant, atent și înțelegător cu alte persoane, cu părerile și valorile acestora. Relația lucrătorului medical cu pacientul și reprezentantul legal al acestuia trebuie

6) responsabilitate, bunăvoință și sollicitudine- în exercitarea profesiei, lucrătorul medical își asumă deplina responsabilitate în legătură cu deciziile luate. Lucrătorul medical în exercitarea profesiei, are obligația de a oferi prioritate calității actului medical, stării de bine și îngrijirii la cel mai înalt nivel a pacientului. Lucrătorul medical este obligat să participe la activități de formare continuă. Lucrătorul medical are drept să colaboreze și să coopereze cu colegii în interesul stării de bine a pacientului.

7) încredere-calificarea profesională și nivelul moral al lucrătorului medical trebuie să inspire încredere pacienților.

8) confidențialitate lucrătorul medical este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor referitoare la pacienți, obținute în cadrul activității sale profesionale.

9) loialitate - lucrătorul medical acționează cu bună-credință în instituția în care își desfășoară activitatea, precum și în relația cu pacientul. Lucrătorul medical are obligația să se abțină de la orice act sau fapt care poate prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele legale ale instituției în care activează sau ale pacientului.

Lucrătorul medical poate folosi numai calificarea la care are dreptul conform pregătirii profesionale, cu excepția cazurilor de urgență vitală.

Dacă lucrătorul medical consideră că nu are suficiente cunoștințe sau experiență pentru a asigura o asistență corespunzătoare, el este obligat să solicite un consult cu alți specialiști sau să trimită bolnavul la aceștia.

IV. Normele de conduit în raport cu pacientul

1. Profesia de medic este incompatibilă cu duritatea, apatia, ignoranța, indiferența, aroganța, nerăbdarea, corupția, discriminarea, stigmatizarea, care afectează și discreditează

atît autoritatea unui lucrător medical ori farmacist în parte, cît și a colectivului profesional, a medicinei în ansamblu.

2. Lucrătorul medical nu pot fi implicați în realizarea unor acte degradante pentru ființa umană.

3. Din momentul în care au răspuns unei solicitări, lucrătorul medical este obligat moral să asigure bolnavului îngrijiri calificate, inclusiv prin trimiterea pacientului la o unitate medicală sau la un specialist cu competențe superioare.

4. Lucrătorul medical nu poate fi obligat să-și exercite profesia în condiții ce ar putea compromite calitatea îngrijirilor medicale și a actelor profesionale, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale vitale.

5. Lucrătorul medical are obligația morală să aducă la cunoștința organelor consultarea altor colegi în cazul în care consideră că propriile abilități și cunoștințe sînt insuficiente.

îngrijiri medicale, una dintre obligațiile morale și profesionale medicale va fi intervenția în sprijinul și protejarea persoanei deținute, prin acordarea serviciilor de asistență medicală.

8. Lucrătorul medical trebuie să ofere pacientului, la cererea acestuia, informații depline și inteligibile despre starea sănătății sale, despre etapele tratamentului, riscurile și rezultatele școntate.

9. În cazul în care sînt întocmite documente medicale, persoana la care se referă documentul emis trebuie informată cu privire la conținutul acestuia.

10. Maniera de a prezenta o informație trebuie să inspire optimism, speranță și încredere, fără a omite importanța factorului psihic.

11. Lucrătorul medical trebuie să respecte dreptul de decizie al pacientului, fără a-i impune convingerile personale și fără a exercita presiuni psihice asupra acestuia.

12. Cu cît actul medical preconizat este mai complex și mai riscant, cu atît informarea pacientului cu privire la riscurile și alternativele posibile trebuie să fie mai amplă.

13. Prognosticul va fi comunicat familiei doar cu consimțămîntul pacientului.

14. Prognosticul grav va fi adus la cunoștința pacientului cu prudență, compasiune și tact, oferind pacientului suport psihoemoțional și speranță, iar în caz de necesitate, referire la consiliere psihologică.

15. Prognosticul real nu se va divulga în cazul în care pacientul declară că nu dorește să afle adevărul. În asemenea caz, pot fi informați unii membri ai familiei pacientului, conform indicațiilor acestuia.

V. Consimțămîntul și acordul informat al pacientului

1. Consimțămîntul pacientului este exprimat în condițiile legii.

2. Consimțămîntul va fi acceptat doar după informarea deplină a pacientului cu privire la diagnostic, prognostic, alternativele terapeutice, riscurile și avantajele acestora.

3. Lucrătorul medical trebuie să se asigure că refuzul pacientului nu este condiționat de un moment de afect sau de suprasolicitare psihică. În cazurile menționate, cu acordul pacientului, lucrătorul medical poate apela la ajutorul rudelor sau al persoanelor apropiate, care pot să ofere suport la luarea deciziei de către pacient. În lipsa acestora, lucrătorul medical va oferi suport pacientului în luarea deciziei în conformitate cu datoria profesională, obiectivul primordial fiind viața, sănătatea și beneficiul pacientului.

4. Consimțământul pacientului poate fi acceptat în formă verbală sau în formă scrisă și se perfectează prin înscrierea în documentația medicală a acestuia, cu semnarea obligatorie de către pacient sau reprezentantul său legal (ruda apropiată) și medicul curant.

VI. Confidențialitatea și secretul profesional

1. Confidențialitatea este dreptul pacientului ca informația referitoare la starea sănătății sale fizice și psihice, aspectele intime ale vieții personale să nu fie divulgată unor persoane terțe, în condițiile Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

2. Lucrătorul medical are datoria de a proteja confidențialitatea informațiilor referitoare la pacienți, obținute în cadrul activității lor profesionale prin procesul de acumulare, stocare, transmitere, primire ori distrugere a datelor.

3. Informațiile confidențiale pot fi dezvăluite:

- cu consimțământul scris al pacientului;
- cu consimțământul scris al tutorelui/reprezentantul legal al pacientului, atunci când vîrsta pacientului sau starea lui de sănătate nu permite consimțirea directă;
- la cererea organelor de urmărire penală, a procuraturii și instanței judecătorești în legătură cu efectuarea urmăririi penale sau a cercetării judecătorești;
- în alte situații prevăzute de lege.

4. Divulgarea informației private, în cazurile menționate la pct.4, trebuie să se facă cu precauție, fără a aduce prejudicii morale pacientului, cu maxim respect pentru demnitatea acestuia.

VII. Situațiile de urgență.

Calamitățile naturale și situațiile de forță majoră

1. Lucrătorul medical care se află lângă un pacient în pericol are obligația să-i acorde asistență la nivelul posibilităților momentului și locului sau să se asigure că acesta primește îngrijirile necesare.

2. În caz de situații excepționale, lucrătorul medical va oferi serviciile profesionale imediat.

3. În caz de forță majoră sau de situații excepționale, lucrătorul medical nu are dreptul să-și abandoneze bolnavii, cu excepția cazului în care autoritatea publică centrală de specialitate permite acest lucru printr-un ordin emis în conformitate cu legea.

VIII. Cercetarea biomedicală pe subiecți umani

1. În studiul pe subiecți umani, binele individului primează asupra binelui societății și al științei.

2. Lucrătorul medical implicat în cercetarea biomedicală (studiu clinic) are datoria de a promova și a proteja viața, sănătatea, intimitatea și demnitatea subiecților umani care participă la cercetare.

3. Lucrătorul medical capabil să-și exprime consimțământul în cunoștință de cauză, după ce reprezentantul său legal și-a dat consimțământul scris, fiind informat despre natura, amploarea, consecințele și riscurile studiului clinic.

4. Subiecții se pot retrage oricând din cercetarea biomedicală (studiu clinic) prin revocarea consimțământului scris, fără prejudicii pentru ei.

5. Refuzul unui pacient de a participa la o cercetare biomedicală (studiu clinic) nu trebuie să influențeze calitatea relației medic-pacient.

6. Forțarea sau inducerea în eroare a subiectului pentru a participa la cercetarea biomedicală (studiu clinic) constituie o gravă încălcare a principiilor eticii medicale și a legislației în vigoare.

7. Orice cercetare biomedicală (studiu clinic) cu implicare de subiecți umani, bolnavi, va trebui să fie avizată în mod obligatoriu de către Comitetul Național de Expertiză Etică pentru Studiul Clinic, abilitat cu acest drept.

IX. Refuzul de a acorda asistență medicală

1. Lucrătorul medical poate refuza efectuarea unui act medical din motive profesionale temeinice, care pot fi argumentate prin lipsa cunoștințelor suficiente și a calificării specifice în domeniu sau în cazul unor posibilități tehnico-materiale limitate pentru a efectua asistența solicitată, cu excepția cazurilor de urgență vitală.

2. Lucrătorul medical poate refuza să acorde asistență medicală atunci când devine imposibilă stabilirea unui contact terapeutic cu pacientul care manifestă o implicare psihoemoțională negativă. În astfel de cazuri lucrătorul medical va trimite pacientul către un alt lucrător medical, cu calificare similară, pentru acordarea asistenței medicale necesare.

X. Atentarea la viața, integritatea fizică și psihică a pacientului.

1. Prin acțiunile lui profesionale, lucrătorul medical nu va supune pacientul la niciun act interzis de lege, chiar dacă există cererea expresă a pacientului respectiv sau a reprezentantului acestuia.

2. Lucrătorul medical nu va asista și nu va îndemna bolnavul la sinucidere sau autovătămări prin sfaturi, recomandări, împrumut de instrumente și alte mijloace, precum și va refuza orice explicație sau ajutor în acest sens.

XI. Normele de conduit colegiale

1. Dacă propunerea pentru consultare vine din partea pacientului sau a rudelor acestuia, medicul curant este obligat să organizeze consultarea.

2. Medicul care anterior a consultat pacientul, la propunerea acestuia sau a rudelor, în cadrul adresării sau internării curențe, nu va examina pacientul din proprie inițiativă, fără aprobarea medicului curant, cu excepția cazurilor de urgență.

3. În cazul în care pacientul este consultat de un grup de specialiști, aceștia se vor retrage pentru a discuta cazul. După ce specialiștii vor ajunge la un consens, medicul curant va comunica bolnavului rezultatul consultării.

4. În cadrul consultului medical comun se va păstra atmosfera de stimă și respect reciproc și se va exclude orice manifestare de superioritate față de medicul curant.

5. Cazul și observațiile critice nu se vor discuta în prezența bolnavului sau a altor persoane străine, chiar dacă este vorba de lucrători medicali sau farmaceutici ce se află în subordine.

6. Dacă în urma consultului de către un grup de specialiști avizul acestora diferă fundamental de cel al medicului curant, pacientul trebuie informat despre acest fapt.

7. Medicul curant este liber să se retragă de la tratament în cazul în care părerea medicilor care au participat la consultare prevalează în opinia pacientului sau a rudelor acestuia.

XII. Erorile medicale și riscul profesional

1. Poziția pe care o adoptă lucrătorii medicali față de eroarea medicală trebuie să aibă drept criteriu esențial binele pacientului.

2. Fiecare lucrător medical este obligat, din punct de vedere moral, să raporteze specialiștilor din domeniu comiterea unor greșeli (erori) proprii sau depistarea acestora în lucrul colegilor săi, în cazul în care pot fi afectate viața, sănătatea și binele pacientului.

3. Lucrătorul medical trebuie să ia în considerare și să evalueze cele mai mici riscuri prin atitudine prudentă și acuratețe, inclusiv riscurile supuse normării, precum și riscurile nesupuse normării, rezultate din situații de urgență..

4. În scopul reducerii erorilor medicale, lucrătorul medical trebuie să acționeze cu prudență, scepticism obiectiv, vigilență și entuziasm moderat, să dea dovadă de scrupulozitate științifică.

XIII. Comitetele de etică (bioetică)

1. Conducerea Centrului „Speranța” este obligată să asigure condiții adecvate pentru activitatea comitetului de etică (bioetică).

2. Cheltuielile ce țin de activitatea comitetului de etică (bioetică) sînt acoperite din contul Centrului.

3. Comitetul de etică (bioetică) este un organ colegial format din persoane competente, care nu sînt salarizate și reprezintă atît domenii medicale, cît și alte domenii.

4. Structura comitetului va fi divizată în două grupuri esențiale: membrii de bază și membrii invitați, la care se apelează în funcție de specifi cul cazului pus în discuție.

5. Membrii comitetului se numesc pe un termen inițial stabilit în regulament, care nu va depăși patru ani. Nici un membru al comitetului, cu excepția specialistului bioetician, dacă acesta există în instituție, nu poate activa mai mult de două mandate, în scopul evitării oricăror forme de interese secundare, generatoare de conflicte.

9. Comitetul de etică (bioetică) se întrunește la cererea pacientului sau a rudelor acestuia, a unui medic sau grup de medici, a administrației Centrului sau a unor organizații neguvernamentale, sindicate.

10. Comitetul de etică (bioetică) are funcție consultativă. În fiecare caz de încălcare a prezentului Cod, comitetul de etică (bioetică) prezintă conducerii Centrului „Speranța” un raport privind examinarea sesizării despre încălcare, care va cuprinde recomandări și modalități de soluționare a acestora.

11. Conducerea (administrația) Centrului va lua decizia finală cu privire la cazurile de încălcare a prezentului Cod și la aplicarea sancțiunilor, care vor fi aduse la cunoștința persoanelor interesate.

12. Raportul comitetului de etică (bioetică) trebuie să fie în acord cu prevederile stipulate în legislația în vigoare a Republicii Moldova și în conformitate cu tratele internaționale.

XIV. Responsabilitatea conducătorilor

1. Conducătorii Centrului „Speranta” trebuie să ia măsurile necesare pentru prevenirea cazurilor de încălcare a normelor de conduită de către lucrătorii medicali.

2. Monitorizarea, informarea și îndrumarea corectă a lucrătorilor medicali pentru o activitate etică și de calitate constituie principalele mijloace de punere în aplicare a prevederilor prezentului Cod, de către administrația Centrului.

3. Conducătorii instituțiilor medicale și farmaceutice au responsabilitatea elaborării unor instrumente de promovare și monitorizare continuă în rîndul denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare, accidentelor fără urmări negative pentru sănătatea pacientului, situațiilor periculoase (metode nesigure de tratament, aparataje medicale nesigure), evenimentelor extreme care pot afecta serios sănătatea pacientului.

XV. Răspunderea privind încălcarea prezentului cod

Angajații sînt obligați să respecte prevederile prezentului Cod.

Sancțiuni:

1. Lucrătorii medicali care încalcă jurămîntul medicului, prezentul Cod, precum și prevederile altor acte normative răspund disciplinar.

2. În funcție de gradul de încălcare a normelor, pot fi aplicate următoarele sancțiuni:

1) avertismentul;

2) mustrarea;

3) mustrarea aspră.

3. Sancțiunile disciplinare se aplică în condițiile Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003.

4. Conducătorul Centrului are obligația de a pune la dispoziția persoanelor cu atribuții de investigare a abaterii disciplinare actele solicitate, precum și orice alte date și informații necesare soluționării cazului.

5. Răspunderea disciplinară a lucrătorului medical nu exclude răspunderea penală, civilă sau contravențională pentru faptele săvârșite în exercitarea profesiei